EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87535
SERVICIO	:	UTI HSC			
FECHA	:	28-06-2024			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ENODINA DEL CARMEN GUTIERREZ MARIN			**RUN**	: 7.806.150-2
F.Nac	: 13-10-1946	**Edad**	: 77 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: TEGUALDA 997 PB. ARAUCANIA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 99053308		
Fecha Ingreso	: 2024-06-18	**Fecha Egreso**	: 28-06-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda global
- Neumonía adquirida en la comunidad basal Derecha, infección por Influenza A
- EPOC exacerbado
2. Obesidad Mórbida
3. Usuaria de O2 domiciliario (EPOC +SAHOS)
4. ICC compensada
5. HTA

Procedimientos realizados en UTI: instalación de línea arterial, instalación CUP, Ventilación no invasiva (18/06 al 24/06/24), Oxigeno por naricera 2 lt (24/06 al 28/06), kinesiterapia respiratoria y motora

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J09-J18-INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, EPOC, ICC, usuaria de O2 domiciliario, sin alergias; consulta en servicio de urgencia HSC por cuadro de tres días caracterizado por compromiso del estado general, tos productiva, exacerbación de su disnea y episodios de desaturación en domicilio. Dentro de exámenes destaca PCR 33.1, GB 13200, GSA pH 7.36, pO2 103, pCO2 81, HCO3 46
Rx Tx con aumento de infiltrado intersticial y foco de condensación basal derecho. Se solicita evaluación de pacte donde se constata paciente en regulares condiciones generales, apoyada con naricera, polipneica, sin UMA, por lo que se decide ingreso a UTI para VMNI.
En UTI se inicia VMNI, broncodilatación, KNT respiratoria, corticoterapia, además manejo depletivo. Se inicia antibiótico empírico. Se solicita panel viral en HSC destacando influenza A y B (-), pero se toma panel viral, el cual resulta positiva para Influenza A. Se inicia oseltamivir. Presenta evolución lenta pero favorable en lo ventilatorio. Se logra destete VMNI el 24/06/24, manteniendo requerimiento FiO2 2lt naricera en forma permanente. Logra deambular con apoyo de andador (se entrega ortesis a la paciente) y apoyo kinésico. Actualmente:
Hemodinamia estable, normotensa, normocárdica, bien perfundida. Al monitor RS.
Ventilando espontáneo, sin UMA, se mantiene apoyada con naricera 2 litros en forma permanente. Sin conexión a VMNI > 72 hrs
GSA pH 7.45 pO2 65 pCO2 65 HCO3 38,1 FiO2 24%
Afebril, parámetros inflamatorios bajos, completó tratamiento antibiótico y antiviral. PCR 16
Función renal conservada, crea 0,9 VFG 60,71 Uremia 60 ELP 138/4,2/99
Metabólicamente estable, HGT dentro de rangos.
Ha tolerado bien KNT motora con apoyo de andador y respiratoria
Se informa a Enfermera de Oxigenoterapia para ajuste de oxigeno domiciliario. En condición de continuar atención en domicilio por HODOM para rehabilitación kinésica.

PLAN DE MANEJO:

KNT respiratorio y motor
Control Progrma oxigeno domiciliario en 1 mes (evaluar si se mantiene requerimiento O2 diurno)
Control en su CESFAM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido - uso andador-
2. Régimen Liviano hiposodico - Restriccion Hídrica 800 ml al día máximo de total de liquidos ingeridos
3. Oxigeno en domicilio: 2 litros a permanencia, intentar disminuir a 1 lt en el día y mantener 2 lt en la noche.
4. Bromuro ipratropio 4 puff c/6hrs con aerocámara
5. Brexotide 2 puff c/12hrs con aerocámara

6. Omeprazol 20 mg 1 capsula antes del desayuno vo
7. Losartán 50 mg 1 comprimido al día vo
8. Furosemida 40 mg 1 comprimido al día vo
9. Bisoprolol 2,5 mg 1/2 comprimido al día vo
10. Control, programa oxigeno domiciliario 1 mes
11. HODOM para KNT respiratoria y motora

EXÁMENES Y RESULTADOS

26/06/24:pH : 7,49, pCO2 : 63,4 * mmHg, pO2 : 74,8 * mmHg, HCO3 ACT. : 49,1 * mmol/L, Sodio (Na) : 140,00 mmol/L, Potasio (K) : 4,60 mmol/L,
Cloro (Cl) : 95,00 * mmol/L.
22/06/24: Glicemia 156, Alb 2.8, A. urico 7.10, PCR 13.7, Nu 49, Urea 105, ELP 142/3.8/94, Hcto 45.5, hb 15, PLT 155, INR 1.21, Tp 75, TTPA 25, Ph 7.47, PCO2 61.1. PO2 77.1, HCO3 45.3
21/06/24: crea 0.90, PCR 20.9, Uremia 105, ELP 145/3.8/94, Leuco 9.000, Hcto 48, Hb 15.8, Plaquetas 175, INR 1.13, Ph 7.39, PCO2 70.3, PO2 72, HCO3 42.6
20/06/24: Crea 0.8, PCR 33, ELP 145/3.9/96,
19/06/24: Alb 3.1, Crea 0.80, Fosforo 4.1, PCR 32.9, NU 43, Uremia 91, ELP 149/4.6/96, INR 1.19, TTPK 24, Ph 7.43, PCO2 65.8, PO2 89.7, HCO3 44.4

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO